

4. □□□□과 세부전문의 자격관리 신고 누락

건강보험심사평가원 심사기준 중 ‘자658 경피적 대동맥판삼입 급여기준’에 따르면 NYHA Class II 이상의 증상이 있는 중증 대동맥판협착증 환자는 심장통합진료를 거쳐 시술 여부를 결정하여야 하며 다음의 요건을 모두 충족한 경우 요양급여를 인정하도록 되어 있다.

[표 4] 경피적 대동맥판삼입 급여 기준

- 다 음 -	
가. 급여대상은 아래 1)~3) 중 어느 하나에 해당하는 경우임	
1) STS score > 8%인 수술 고위험군	
2) 80세 이상	
3) 마. 1)의 심장통합진료에 참여한 심장혈관흉부외과 전문의 전원이 수술 불가능하다고 판단한 환자	
나. 급여횟수는 최초 시행 시 1회 인정하며, 1회를 초과하는 경우 비급여임	
다. 금기증(내용 생략)	
라. 시설·장비·인력 및 실적 기준	
1) 심장 수술이 가능한 시설과 체외순환막형산화용기기(Extra Corporeal Membrane Oxygenator, ECMO) 또는 심장 수술용체외순환(심폐기) 구비하여야 함	
2) 인력은 가), 나)를 모두 충족하여야 하며 당해 요양기관에 상근하여야 함	
가) 분과 전문의 자격 취득 후 5년 이상의 순환기내과 진료 경험이 있는 순환기내과 분과전문의 2인 이상	
나) 전문의 자격 취득 후 5년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 심장혈관흉부외과 전문의 2인 이상	
3) 연간 실적(내용 생략)	
4) 동 시술을 실시하고자 하는 요양기관은 매년 건강보험심사평가원에 상기 라. 1)~3)의 기준에 적합한 증빙 서류를 첨부하여 아래 표의 신고 주기에 따라 신고하여야 하며, 변경 사항이 발생할 경우 지체 없이 변경 신고하여야 함	

‘경피적 대동맥판삼입 급여기준’에 따라 동 시술을 하고자 하는 요양기관은 매년 건강보험심사평가원 보건의료자원통합신고포털을 통해 시설·장비·인력·실적 기준의 충족을 증빙하는 서류를 첨부하여 신고해야 한다. 실시기관 신고 이후 변경 사항(특히, 인력 기준)이 발생하는 경우 건강보험심사평가원 보건의료자원통합신고포털을 통해 지체 없이 변경 신고하여야 하며, 만일 동 시술 시행 기간에 시설·장비·인력·실적 기준 등을 미충족하였거나 보건의료자원통합신고포털에 변경 신고하지 않을 시 요양급여비용을 산정할 수 없다.

2020년 9월부터 2024년 4월까지 경피적 대동맥판삼입 환자의 내역을 확인한 결과, 병원은 전문의 자격관리 신고를 담당하는 주무 부서가 없어 □□□□과 세부전문의 자격관리 변경신고가 누락되고 있었다. 이로 인해 ‘전문의 자격 취득 후 5년 이상의 심혈관 수술 경험이 있는 심장혈관흉부외과 전문의 2인 이상’의 요양급여조건을 충족하지 않아 1건이 삭감(삭감액 31,545,000원)되고, 2건(반송액 70,015,920원)이 반송되었다.

[표 5] 경피적 대동맥판삼입 환자 삭감 및 반송 내역

(단위: 원)								
연번	분류	환자번호	성명	입원기간	청구액	삭감액	진행상황	비고
1	TAVI 삭감	■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■	-	31,545,000	이의신청 진행중	
2	TAVI 반송	■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■	34,054,740	-	2023.12. 1001차로 보완청구함	
3	〃	■■■■	■■■■	■■■■■■■■■■	35,961,180	-	2023.11. 1001차로 보완청구함	
합계					70,015,920	31,545,000		

<조치할 사항>

- 【시정】 ① □□□□과 세부전문의 자격 증빙서류를 보완하여 삭감된 요양급여비용을 받을 수 있도록 하고,
- ② 인력기준 등 변경신고 누락으로 인한 동일한 사례가 발생되지 않도록 관련 부서와 협의하여 업무처리 절차를 마련하기 바랍니다.